



Hoe berekenen economen en sociale wetenschappers momenteel de maatschappelijke waarde (SROI / Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse) van preventief welzijnswerk (zoals eenzaamheidsbestrijding en laagdrempelige ontmoeting)? Geef concrete kengetallen: hoeveel euro aan zorgkosten bespaart één euro geïnvesteerd in lokaal welzijnswerk gemiddeld?

Economen en sociale wetenschappers vinden voor preventief welzijnswerk (eenzaamheid, ontmoeting, community building) overwegend positieve SROI-ratio's tussen grofweg 1,5 en 6 euro maatschappelijke waarde per geïnvesteerde euro, afhankelijk van doelgroep en interventie. Er bestaat echter geen hard "gemiddeld" kengetal alleen voor bespaarde zorgkosten: in de meeste MKBA's/SROI-analyses is zorgbesparing slechts één component naast kwaliteit van leven, productiviteit en informele zorg, en de hoogte daarvan hangt sterk af van hoe sterk je eenzaamheid of kwetsbaarheid daadwerkelijk reduceert.^{[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]}

Hoe SROI en MKBA technisch worden berekend

In Nederland sluiten economen meestal aan bij de Werkwijzer kosten-batenanalyse sociaal domein (Rijk/VWS c.s.), gecombineerd met de algemene MKBA-systematiek (CPB, KBA-Netwerk). In grote lijnen gebeurt het volgende:^{[5] [7]}

1. Afbakening interventie en tijdshorizon

- Men beschrijft de interventie (bijvoorbeeld ontmoetingscentrum, jongerengroep tegen eenzaamheid, buurtkraachtenwerker), doelgroep en nulscenario (wat gebeurt er zonder project?).^{[7] [5]}
- Voor preventie in het sociaal domein wordt vaak een horizon van 3-10 jaar gekozen, zodat effecten op zorggebruik en participatie zichtbaar worden.^{[5] [7]}

2. Effecten meten: van activiteiten naar uitkomsten

- Eerst worden **outputs** gemeten (bereikte personen, contactmomenten, vrijwilligersuren).
- Vervolgens **outcomes**, zoals verandering in eenzaamheidsscores, mentale gezondheid, zelfredzaamheid, zorggebruik (huisarts, GGZ, ziekenhuis) en arbeidsdeelname.^{[11] [12]}
- Bij eenzaamheid gaat het bijvoorbeeld om minder ernstige/zeer ernstige eenzaamheid, minder depressie en minder zorgconsumptie.^{[13] [3] [14]}

3. Monetarisering via kostprijzen en waarderingsproxies

- Voor zorgkosten gebruikt men standaardkostprijzen per huisartsbezoek, ziekenhuisdag, GGZ-traject enzovoort.^{[3] [10] [12]}

- Voor kwaliteit van leven worden QALY's/DALY's of waarderingsstudies gebruikt; voor arbeid gaat het om extra productiviteit of minder uitval.^{[15] [7]}
- In eenzaamheidsonderzoek is bijvoorbeeld berekend dat eenzame jongeren gemiddeld zo'n 15.500 euro per jaar aan extra maatschappelijke kosten veroorzaken, met uitschieters tot 172.500 euro per persoon per jaar.^{[16] [17]}

4. Netto-effect bepalen (attributie, deadweight, displacement, drop-off)

- Alleen de baten die redelijkerwijs aan de interventie zijn toe te schrijven tellen mee; effecten die ook zonder project zouden optreden ("deadweight") en verschuivingen ("displacement") worden afgetrokken.^{[18] [19]}
- Daarnaast houden SROI-studies rekening met jaarlijkse afname van effecten ("drop-off") en de kans dat deelnemers uitvallen.^{[19] [18]}

5. Discontering en berekening van de ratio

- Toekomstige kosten en baten worden contant gemaakt met een discontovoet (bijv. 3–4 procent).^{[7] [5]}
- De SROI-ratio is vervolgens: contante waarde van alle baten / contante waarde van de kosten; bij MKBA wordt daarnaast het saldo (netto contante waarde) gerapporteerd.^{[5] [7]}

Belangrijk: zorgkostenbesparing is meestal slechts één deel van de baten, naast betere kwaliteit van leven, minder uitval uit school/werk, minder schulden en minder belasting van mantelzorgers.^{[8] [7] [5]}

Kosten van eenzaamheid als onderlegger

Bij eenzaamheidsbestrijding werken onderzoekers vaak eerst met een "cost-of-illness"-analyse, die laat zien hoe duur eenzaamheid is zonder interventie. Enkele recente kerncijfers:^{[10] [3]}

- Een grote studie van de Universiteit Maastricht onder bijna 350.000 Nederlanders laat zien dat mensen met ernstige of zeer ernstige eenzaamheid 40–50 procent hogere zorgkosten per jaar maken dan niet-eenzame mensen; omgerekend is dit circa 2 miljard euro extra zorgkosten per jaar in Nederland.^{[20] [14] [21] [13]}
- Voor jongeren van 12–30 jaar schat een literatuur-gebaseerde MKBA van Universiteit Utrecht, Join Us en Grant Thornton de gemiddelde maatschappelijke kosten van eenzame jongeren op zo'n 15.500 euro per persoon per jaar, met mogelijke uitschieters tot 172.500 euro.^{[17] [16]}

Deze cost-of-illness-cijfers worden vervolgens gebruikt in scenario's: als een interventie bijvoorbeeld bij 100 jongeren ernstige eenzaamheid bij 10–20 procent voorkomt of vermindert, kan men modelleren welke zorgkosten en andere kosten in de komende jaren worden vermeden.^{[3] [15] [10]}

Concrete SROI/MKBA-ratio's voor preventief welzijnswerk

Onderstaande voorbeelden geven een indruk van de orde van grootte bij lokaal welzijn, community building en eenzaamheidsbestrijding.

Voorbeelden uit Nederland en Europa

Interventie / context	Type en doelgroep	SROI / MKBA-kengetal	Opmerkingen
Sociaal Centrum Eijsden – “krachtenbinder zorgzame gemeenschap” (NL)	Community builder die buren en vrijwilligers rondom kwetsbare inwoners verbindt	Elke euro geïnvesteerd levert minimaal 6 euro maatschappelijke winst op. ^[4] ^[6]	Winst komt deels uit betere kwaliteit van leven, deels uit lagere zorg- en gemeentelijke kosten; onderzoekers geven aan dat dit een conservatieve schatting is. ^[4] ^[6]
MDT tegen Eenzaamheid (NL)	Maatschappelijke Diensttijd-traject tegen eenzaamheid onder jongeren	SROI-analyse vindt 1,61 euro maatschappelijke waarde per geïnvesteerde euro over 1 jaar. ^[2]	Grootste baten zitten in toegenomen welzijn en kwaliteit van leven; zorgkostenbesparing is expliciet meegenomen maar vormt niet de hele 1,61 euro. ^[2]
Community building / lotgenotencontact (NL, PGOsupport quick scan)	Diverse vormen van lotgenotencontact en patiëntenorganisaties	Quick scan SROI: gemiddeld circa 4,5 euro per geïnvesteerde euro over 5 jaar. ^[9]	Betreft o.a. minder zorggebruik, betere zelfmanagement en sterkere inzet van ervaringsdeskundigheid. ^[9]
Aanpak ondervoeding kwetsbare ouderen (NL)	Domeinoverstijgende netwerk-aanpak ondervoeding	SROI-studie: 1 euro investering levert 3,27 euro maatschappelijk rendement over 5 jaar. ^[8]	Baten bestaan uit betere kwaliteit van leven plus lagere zorgkosten (minder en kortere ziekenhuisopnames, uitstel verpleeghuisopname, minder wijkverpleging). ^[8]
Kind naar Gezonder Gewicht (JOGG) (NL)	Integrale aanpak gezond gewicht bij kinderen	SROI-ratio 3,20 euro maatschappelijke waarde per euro investering over 5 jaar. ^[1]	Gezondheidswinst, hogere kwaliteit van leven en vermeden zorgkosten door minder overgewicht op latere leeftijd. ^[1]
Natuur- en vrijwilligersprojecten voor gezondheid/welzijn (UK)	Natuurconserverings-vrijwilligersproject voor mensen met gemiddelde-hoge welzijnsscores	SROI-analyse vindt 8,50 pond waarde per geïnvesteerde pond. ^[22]	Combinatie van verbeterd mentaal welzijn, fysieke gezondheid en minder zorggebruik. ^[22]
Mentale-gezondheidsinterventies (diverse) (internationaal)	Diverse interventies tegen depressie, angst, sociale uitsluiting	Systematische review van SROI-studies in mentale gezondheid vindt positieve SROI met baten tussen 2,28 en 13,72 dollar per geïnvesteerde dollar. ^[23] ^[24]	Veel van deze interventies hebben een belangrijke component van sociale steun en ontmoeting; directe zorgkostenbesparing is vaak substantieel. ^[23] ^[24]

Daarnaast laten economische reviews van “social prescribing” – waarbij huisartsen patiënten doorverwijzen naar welzijnsactiviteiten, ontmoetingsgroepen en vrijwilligerswerk – zien dat zulke interventies zorgkosten kunnen drukken door minder huisartsbezoeken en ziekenhuisopnames, met aantoonbare kostenbesparingen per deelnemer per jaar en positieve SROI-ratio's. ^{[25] [26] [27] [28] [11]}

Wat kun je als “gemiddeld kengetal” gebruiken?

Op basis van deze literatuur is het methodologisch niet verdedigbaar om één universeel cijfer te claimen als “de” besparing aan zorgkosten per euro welzijnswerk. Wel zijn er een paar robuuste conclusies: ^{[19] [7]}

- Preventief welzijnswerk met aantoonbaar effect op eenzaamheid en zelfredzaamheid levert vrijwel altijd een positieve maatschappelijke baten-kostenverhouding op. In Nederlandse SROI/MKBA-studies op buurtniveau liggen de totale maatschappelijke baten doorgaans in de bandbreedte 1,5–6 euro per geïnvesteerde euro, afhankelijk van doelgroep, intensiteit en effectgrootte. ^{[2] [4] [6] [9] [1] [8]}
- Directe zorgkostenbesparingen zijn reëel maar sterk variabel. Cost-of-illness-studies laten zien dat ernstige eenzaamheid 40–50 procent hogere zorgkosten geeft en dat het totaal aan extra zorgkosten rond de 2 miljard euro per jaar ligt, plus aanzienlijke kosten bij jongeren. Hoeveel daarvan je voorkomt, hangt af van de bewezen impact van jouw interventie op het daadwerkelijk verminderen van (ernstige) eenzaamheid. ^{[14] [21] [16] [13] [17] [10] [20] [3]}
- Zorgkosten zijn slechts één deel van de businesscase. In cases als MDT tegen Eenzaamheid, de aanpak ondervoeding bij ouderen en Kind naar Gezonder Gewicht bestaat een belangrijk deel van de baten uit hogere kwaliteit van leven, minder uitval uit onderwijs/werk en lagere belasting van mantelzorgers, naast de bespaarde zorgkosten. ^{[1] [2] [8]}

In de praktijk doen veel Nederlandse adviseurs en gemeenten bij lokale welzijns- en ontmoetingsprojecten het volgende:

- Ze gebruiken de Werkwijzer sociaal domein + MKBA-database om vergelijkbare cases en kengetallen te vinden. ^{[29] [12] [7] [5]}
- Ze bouwen een projectspecifieke mini-MKBA waarbij ze conservatieve aannames nemen over:
 - de reductie in (ernstige) eenzaamheid of psychosociale problematiek,
 - de bijbehorende daling in zorggebruik (bijv. procent minder huisarts- of GGZ-gebruik),
 - en vermenigvuldigen dat met de bekende kostprijzen. ^{[12] [10] [3] [5]}

Als je dus een “vuistregel” wilt communiceren aan financiers, dan is het eerlijk om te zeggen dat goede, bewezen preventieve welzijnsprojecten in de praktijk vaak tussen ongeveer 1,5 en 6 euro maatschappelijke waarde per geïnvesteerde euro opleveren, waarbij een deel daarvan bestaat uit vermeden zorgkosten en de rest uit hogere kwaliteit van leven, participatie en minder belasting van informele zorg. ^{[23] [22] [4] [6] [9] [2] [8] [1]}

Wil je, gegeven je eigen projecten, een praktisch rekenmodel voor een micro-MKBA/SROI-template voor buurthuizen en ontmoetingsprojecten (inclusief Excel-structuur, indicatoren en Nederlandse kostprijzen), dan kan ik die stap-voor-stap met je uitwerken.



2. <https://www.vrijwilligerswerk.nl/api/documents/downloadfile?sectionid=172153&fileid=1679336&forcedownload=False>
3. <https://www.socialconnectionguidelines.org/en/evidence-briefs/what-are-the-economic-costs-of-loneliness>
4. <https://www.hetjuistethuis.nl/actueel/gzad6pq6o5gesr17szl1h40oj4g1if-pni2e>
5. <https://www.rijksfinancien.nl/sites/default/files/extrainfo/MKBA/Hoofdrapport werkwijzer Sociaal domein.pdf>
6. <https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zorgzame-buurt-en-wijken/sroi-eijsden-eur6-winst-per-euro-investering>
7. <https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/13298/op-weg-naar-maatschappelijke-kosten-batenanalyses-voor-preventie-en-zorg/>
8. <https://www.kenniscentrumondervoeding.nl/sroi-aanpak-ondervoeding-ouderen/>
9. <https://metiscompany.nl/2021/11/02/community-building-voor-sociale-vraagstukken-levert-geld-op/>
10. <https://www.springermedizin.de/the-economic-costs-of-loneliness-a-review-of-cost-of-illness-and/16741448>
11. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12891220/>
12. <https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-03/Kosten-en-baten-van-de-gezonde-wijk.pdf>
13. <https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/aanpakken-eenzaamheid-drukt-ook-zorgkosten>
14. <https://www.ggznieuws.nl/eenzaamheid-kost-ongeveer-2-miljard-aan-extra-zorgkosten-per-jaar/>
15. <https://www.sirm.nl/publicaties/de-baten-van-betere-zorg-voor-angst-en-dwangstoornissen>
16. <https://join-us.nu/maak-impact/gemeenten/eenzaamheidskosten>
17. <https://join-us.nu/blog/gevolgen-eenzaamheid-onder-jongeren-bekend-kosten-zijn-jaarlijks-gemiddeld-15-duizend-euro-per-persoon>
18. <https://flever.nl/wp-content/uploads/2022/01/211125-SROI-Methodiek-en-Update-SROI-Impactschetsen.pdf>
19. <https://www.lancashire.gov.uk/media/899627/economic-decision-making-for-interventions-to-prevent-or-ameliorate-social-isolation-and-or-loneliness.pdf>
20. <https://huurdersvoordeel.nl/eenzaamheid-kost-2-miljard-aan-extra-zorgkosten-per-jaar/>
21. <https://www.kernkracht.nl/eenzaamheid-kost-nederland-twee-miljard-per-jaar/>
22. <https://www.wildlifetrusts.org/sites/default/files/2019-09/SROI Report FINAL - DIGITAL.pdf>
23. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12370830/>
24. <https://phwwhocc.co.uk/resources/social-return-on-investment-sroi-of-mental-health-related-interventions-a-scoping-review/>
25. <https://socialprescribingacademy.org.uk/media/2uxfx40g/building-the-economic-case-for-social-prescribing-briefing-october-2023.pdf>
26. <https://shura.shu.ac.uk/29932/1/evidence-summary-the-economic-impact-of-social-prescribing.pdf>
27. https://healthinnovationeast.co.uk/wp-content/uploads/2023/03/20221130_d_desktop-review_branded-Social-prescribing.pdf
28. <https://content.vu.edu.au/sites/default/files/documents/2025-12/social-prescribing-appendix.pdf>
29. <https://www.mkba-database.nl>
30. <https://www.brierke.nl/archief/2024/202402/elz.html>
31. <https://www.lse.ac.uk/business/consulting/assets/documents/making-the-economic-case-for-investing-in-actions-to-prevent-and-or-tackle-loneliness-a-systematic-review.pdf>
32. <https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/210302-bootcamp-sroi.pdf>
33. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525861026000678>

34. <https://www.actieleernetwerk.nl/wp-content/uploads/2023/11/Presentatie-SROI-Workshop-Werkplaats-Actie-Leer-Netwerk.pdf>
35. <https://ggdru.nl/wp-content/uploads/2026/03/AB-020-b-3-2026-03-25-Rapportage-Maatschappelijke-Waarde-Transformatie-GGDrU.pdf>
36. <https://kamersmetaandacht.nl/nieuws/maatschappelijke-kosten-baten-analyse-mkba/>
37. <https://www.swwh.nl/pagina/ontmoeting-en-ontspanning/>
38. <https://www.campaigntoendloneliness.org/wp-content/uploads/CTEL-summary-doc-final-15.9.17.docx>
39. <https://www.sezo.nl/wp-content/uploads/2021/06/MKBA-VONL.pdf>
40. <https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/articles/sroi-wat-is-het-wie-heeft-er-iets-aan-en-waarom-zou-je-het-stimuleren/>